

ENCAPS / SERUMS 2026-II

Salud Publica I-3 - Vigilancia Epidemiologica

20 preguntas - nivel examen

Marque una sola alternativa por pregunta. Resuelva sin material de consulta. Claves verificadas contra la Directiva Sanitaria 046-MINSA/DGE-V.01 (RM 506-2012), la Directiva Administrativa 341-MINSA/CDC-2023 (RENACE) y los compendios de Salud Publica.

1. En una comunidad dispersa de Loreto, los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) capacitados reportan al EESS los casos de fiebre y diarrea que detectan entre sus vecinos, antes de que acudan al establecimiento. ¿Qué tipo de vigilancia es?

- A) Centinela
- B) Comunitaria
- C) Pasiva
- D) Sindrómica

2. La DIRESA designa 5 hospitales con laboratorio para monitorear la tendencia estacional de influenza, sin pretender captar todos los casos de la región. ¿Qué tipo de vigilancia aplica?

- A) Activa
- B) Universal
- C) Centinela
- D) Comunitaria

3. Ante un aumento de casos febriles sin diagnóstico confirmado, el EESS notifica el 'síndrome febril icterico' para gatillar la respuesta sin esperar el laboratorio. Esta modalidad de alerta-respuesta se rige por:

- A) Directiva 065-MINSA/OGE-V.01 (RM 581-2005), Vigilancia Sindrómica
- B) Directiva 046-MINSA/DGE (RM 506-2012)
- C) Directiva 341-MINSA/CDC-2023 (RENACE)
- D) NTS 078-2009 Vigilancia Perinatal

4. Tras notificarse un caso de sarampión, el equipo del EESS realiza barrido casa por casa en 5 manzanas buscando febriles con exantema no notificados. ¿Qué está ejecutando?

- A) Vigilancia pasiva reforzada
- B) Búsqueda activa comunitaria
- C) Vigilancia centinela
- D) Notificación negativa

5. El personal de salud ambiental inspecciona viviendas y calcula el índice aédico, sin registrar casos humanos. Esta vigilancia es de tipo:

- A) Comunitaria
- B) Sindrómica
- C) Entomológica (del vector)
- D) Centinela

6. En un comedor comunal de Ucayali, de 80 personas que consumieron el guiso, 24 enfermaron en 10 horas. ¿Cuál es la tasa de ataque?

- A) 30%
- B) 24%
- C) 3.3%
- D) 80%

7. En un distrito de 20 000 habitantes ocurren 10 muertes por neumonía en el año. ¿Qué indicador expresa el impacto de esas muertes en TODA la comunidad, y cuánto vale?

- A) Letalidad, 10%
- B) Tasa de mortalidad, 50 por 100 000
- C) Tasa de ataque, 0.05%
- D) Prevalencia, 10 casos

8. En una comunidad de 5 000 personas hay actualmente 250 personas con hipertensión diagnosticada. ¿Qué indicador es y cuánto vale?

- A) Incidencia, 5%
- B) Prevalencia, 5%
- C) Tasa de ataque, 5%
- D) Letalidad, 5%

9. En un brote, el número reproductivo efectivo (R_t) cae a 0.7 tras la intervención. ¿Qué significa?

- A) La epidemia sigue creciendo
- B) La epidemia se mantiene estable
- C) La epidemia está en descenso y tenderá a extinguirse
- D) No puede interpretarse sin conocer la letalidad

10. Fallece una gestante de 30 años por eclampsia en un EESS I-4. Además de la notificación, ¿qué norma específica rige la vigilancia de este evento?

- A) Directiva 036-MINSA/DGE-V.01 (RM 634-2010), vigilancia de muerte materna
- B) Directiva 047-MINSA/DGE (RM 545-2012), brotes
- C) NTS 078-2009, vigilancia perinatal y neonatal
- D) Reglamento Sanitario Internacional 2005

11. De los siguientes eventos, ¿cuál se notifica de forma CONSOLIDADA y no individual?

- A) Tuberculosis pulmonar
- B) Sarampión
- C) Enfermedad diarreica aguda (EDA)
- D) Muerte materna

12. Una unidad notificante deja de enviar reportes durante 4 semanas seguidas, sin que se sepa si hubo o no casos. ¿Cómo se denomina esta situación?

- A) Notificación negativa
- B) Silencio epidemiológico
- C) Subregistro pasivo
- D) Cierre de base de datos

13. Un paciente convivió con un enfermo de tos ferina confirmado por laboratorio y presenta tos paroxística. No se le tomó muestra. Según la Directiva 046, ¿cómo se clasifica?

- A) Caso sospechoso
- B) Caso probable
- C) Caso confirmado por nexo epidemiológico
- D) Caso descartado

14. Un caso notificado como sospechoso de dengue resulta con IgM negativa y se documenta otro diagnóstico. ¿Cómo queda clasificado?

- A) Caso probable
- B) Caso descartado
- C) Caso confirmado
- D) Se mantiene sospechoso hasta el cierre anual

15. En Lima se registra un caso de malaria en un paciente que estuvo dos semanas en Loreto y no salió de Lima antes ni después. Según la Directiva 046, el caso es:

- A) Autóctono
- B) Importado
- C) Confirmado por nexo epidemiológico
- D) Sospechoso

16. En un colegio se detectan 3 casos de parotiditis en la misma aula en 10 días, agrupados en tiempo y espacio, aún en investigación. ¿Cómo se denomina esta agrupación?

- A) Pandemia
- B) Conglomerado (cluster)
- C) Endemia
- D) Caso índice

17. Una enfermedad transmisible se propaga simultáneamente en varios continentes con transmisión comunitaria sostenida. ¿Qué escala corresponde?

- A) Epidemia
- B) Pandemia
- C) Endemia elevada
- D) Brote multinacional

18. Según la Directiva Administrativa 341-MINSA/CDC-2023, el nivel LOCAL de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) está constituido por:

- A) El Centro Nacional de Epidemiología (CDC)
- B) Las DIRESA / GERESA / DIRIS
- C) Las unidades notificantes (establecimientos de salud)
- D) Las Redes Integradas de Salud (RIS)

19. En un brote de tuberculosis en un penal, el mecanismo por el cual el bacilo abandona al enfermo al toser corresponde a:

- A) Puerta de entrada
- B) Puerta de salida
- C) Reservorio
- D) Vía de transmisión

20. El boletín epidemiológico semanal que la DIRESA envía a los EESS con el análisis de la semana corresponde a qué etapa del proceso de vigilancia?

- A) Recolección
- B) Análisis
- C) Difusión
- D) Intervención